

Hernia inguinal estrangulada

1. Introducción y relevancia clínica

La **hernia inguinal estrangulada** se define como aquella en que el contenido herniado (usualmente intestino delgado o epiplón) **queda atrapado en el saco herniario sin posibilidad de reducción**, con **compromiso vascular** progresivo que puede llevar a **isquemia, necrosis y perforación intestinal**.

Es una **urgencia quirúrgica verdadera**: requiere diagnóstico clínico rápido y **resolución quirúrgica inmediata**, ya que el riesgo de necrosis intestinal aumenta significativamente después de **6 horas de evolución**.

En Chile, su manejo se basa en las **Guías MINSAL de Abdomen Agudo (2022)** y en protocolos de la **Sociedad de Cirujanos de Chile (SOCHICH)**. Es una causa frecuente de **abdomen agudo obstructivo**, tanto en adultos (hernia inguinal directa o indirecta) como en niños (hernia inguinal congénita incarcerada).

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Hernia inguinal: recordatorio anatómico

Una **hernia inguinal** es la protrusión de contenido abdominal (intestino, epiplón, vejiga, ovario) a través del **conducto inguinal**.

- **Hernia inguinal indirecta**: el contenido protruye a través del **anillo inguinal interno**, sigue el **trayecto del cordón espermático** y puede llegar al escroto (más frecuente en hombres jóvenes y en niños).
 - **Hernia inguinal directa**: protruye a través del **triángulo de Hesselbach**, por debilidad de la pared posterior del conducto inguinal (más frecuente en adultos mayores).
-

2.2. Mecanismo fisiopatológico de la estrangulación

1. Inicialmente ocurre **encarcelamiento**: el contenido herniario queda **atrapado** pero sin compromiso vascular.

2. Posteriormente, la **presión del anillo herniario** compromete el retorno venoso → **congestión y edema**.
3. El edema agrava la compresión → **interrupción arterial, isquemia y necrosis** intestinal.
4. Finalmente, puede producirse **perforación y peritonitis**.

El proceso puede completarse en pocas horas, por lo que la demora diagnóstica **incrementa la mortalidad hasta 20–30%**.

2.3. Factores predisponentes

- Hernia conocida sin corrección.
 - Esfuerzos físicos intensos.
 - Tos crónica, constipación.
 - Ancianos o pacientes debilitados.
 - En niños: persistencia del **conducto peritoneo-vaginal** (hernia congénita).
-

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Cuadro clínico típico

- **Dolor inguinal intenso y súbito**, de carácter progresivo, que no cede con reposo ni reducción manual.
 - **Tumoración inguinal irreductible**, tensa y muy dolorosa.
 - **Signos de obstrucción intestinal**: distensión abdominal, náuseas, vómitos, ausencia de deposiciones y gases.
 - **Fiebre, taquicardia y leucocitosis** en fases avanzadas.
 - Si hay necrosis o perforación → **peritonitis**.
-

3.2. Signos físicos característicos

Signo	Descripción
Masa inguinal irreductible	Dura, tensa, muy dolorosa.
Ausencia de impulso herniario	No aumenta con tos ni maniobra de Valsalva.
Piel tensa, eritematosa	Sugiere isquemia avanzada.
Dolor intenso a la palpación	Irradiado a abdomen bajo o escroto.
Silencio abdominal	En fases de obstrucción avanzada.
Si la masa es reductible y no hay signos de isquemia, se trata de hernia incarcerada , no estrangulada.	

3.3. Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Diferenciación clave
Hernia inguinal incarcerada	No hay signos de isquemia ni dolor intenso.
Adenitis inguinal	Dolor local sin masa reducible, con signos infecciosos locales.
Torsión testicular	Dolor testicular agudo, reflejo cremastérico ausente.
Hidrocele agudo	Masa indolora, transluminación positiva.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

El diagnóstico es **principalmente clínico**.

Los exámenes se utilizan para evaluación general y planificación quirúrgica.

4.1. Laboratorio

- Hemograma: leucocitosis, neutrofilia.
- PCR elevada si hay necrosis o sepsis.
- Electrolitos y función renal (por deshidratación y vómitos).
- Gases arteriales: acidosis metabólica si hay necrosis intestinal.

4.2. Imágenes

- **Ecografía inguinal:** útil en duda diagnóstica, muestra asas intestinales con alteración del flujo o líquido perilesional.
- **TAC abdomen/pelvis:** en adultos obesos o hernias femorales sospechosas.
 - Muestra contenido herniario, signos de obstrucción, neumatosis o líquido libre.

☐ No se debe retrasar la cirugía esperando estudios si la sospecha clínica es alta.

4.3. Criterios clínicos de estrangulación

1. **Masa inguinal dolorosa, irreductible.**
2. **Ausencia de impulso herniario.**
3. **Dolor intenso, persistente y progresivo.**

4. **Signos de obstrucción intestinal.**
 5. **Compromiso sistémico:** fiebre, taquicardia, leucocitosis, acidosis.
 6. **Piel eritematosa o necrosada** sobre la hernia.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1. Principios generales

La hernia inguinal estrangulada es una **urgencia quirúrgica absoluta**: el tratamiento es **operatorio inmediato**, luego de una **reanimación inicial breve**.

Medidas preoperatorias

1. **Ayuno absoluto.**
 2. **Vía venosa periférica amplia.**
 3. **Reposición de volumen (cristaloides IV).**
 4. **Antibióticos profilácticos de amplio espectro:** cefazolina + metronidazol.
 5. **Analgesia y sedación prudente.**
 6. **Sonda nasogástrica:** descompresión gástrica.
 7. **Monitoreo de signos vitales.**
-

5.2. Tratamiento quirúrgico

1 ☐ **Herniotomía / Hernioplastia urgente**

El procedimiento depende de la viabilidad intestinal y el contexto del paciente.

A. Técnica general (abierta):

1. Incisión inguinal estándar.
2. Apertura del saco herniario y evaluación del contenido.

3. **Reducción suave** del contenido herniado.

4. Evaluar **viabilidad intestinal**:

- **Color rosado, peristaltismo y pulso mesentérico** → viable.
- **Cianosis, flacidez o ausencia de pulso** → isquemia o necrosis → resección.

B. Si el intestino está viable:

→ **Reducción + hernioplastía inmediata.**

- Técnica de **Bassini, Lichtenstein (malla), Shouldice**, según edad y contexto.

C. Si hay necrosis intestinal:

→ **Resección intestinal + anastomosis primaria**, y cierre del defecto sin malla (riesgo infeccioso alto).

→ Hernioplastía diferida tras recuperación.

D. En lactantes / niños:

→ **Herniotomía simple** (ligadura del saco herniario) sin malla.

→ En casos bilaterales, reparación contralateral electiva.

5.3. Hernia femoral estrangulada (mujeres)

- Alta frecuencia de **necrosis intestinal** por orificio rígido.
- **Cirugía urgente** con incisión inguinal o crural amplia.
- En mujeres, considerar exploración de la **fosa contralateral**.

5.4. Cuidados postoperatorios

- **Control de dolor y balance hídrico.**
- **Antibióticos 24–48 h** si hubo resección intestinal.

- **Dieta progresiva** al recuperar tránsito.
 - **Movilización temprana** y prevención de trombosis venosa profunda.
 - Educación: evitar esfuerzos, control del peso, corregir tos o constipación.
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1. Complicaciones postoperatorias

Complicación	Descripción / Manejo
Infección de herida o malla	Cuidado local, antibióticos. Si sepsis, retirar malla.
Recidiva herniaria	1–5%; asociada a técnica deficiente o tos crónica.
Isquemia intestinal no reconocida	Sepsis postoperatoria; requiere reexploración.
Atrofia testicular	Por lesión de vasos espermáticos (1–2%).
Fístula entero-cutánea	Tras necrosis o resección intestinal fallida.
Dolor inguinal crónico	Lesión nerviosa, fibrosis o atrapamiento en la malla.

6.2. Pronóstico

- Excelente si se trata precozmente (<6 horas).
- Mortalidad <1% en hernias sin necrosis; 5–10% si hay resección intestinal.

- En ancianos o pacientes sépticos, la mortalidad puede superar 15%.
 - En niños, la **recuperación es rápida** si el diagnóstico es temprano.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Dolor inguinal súbito + masa irreductible = hernia estrangulada** hasta demostrar lo contrario.
 2. **No intentar reducción forzada (“taxis”)**: riesgo de necrosis y perforación dentro del abdomen.
 3. **Cirugía urgente = único tratamiento curativo.**
 4. En hernias con intestino viable, realizar **hernioplastia inmediata** (Lichtenstein).
 5. Si hay necrosis, **resección intestinal + cierre sin malla.**
 6. En niños, el tratamiento es **herniotomía simple sin malla.**
 7. En mujeres, descartar **hernia femoral**, más propensa a estrangularse.
-



Errores comunes

- Intentar **reducir a la fuerza** una hernia estrangulada.
- Retrasar la cirugía para hacer estudios innecesarios.
- No administrar **antibióticos y líquidos** antes de operar.
- No explorar adecuadamente la **viabilidad intestinal.**
- Usar **malla en campo contaminado o tras resección intestinal.**

- Olvidar reparar la **hernia contralateral** en niños pequeños.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Definición:** encarcelamiento herniario con compromiso vascular → **isquemia intestinal**.
2. **Clínica:** dolor inguinal agudo, masa irreductible, sin impulso tusígeno, vómitos y signos obstructivos.
3. **Diagnóstico:** principalmente **clínico**; ecografía/TAC si duda.
4. **Tratamiento:** **cirugía urgente** (hernioplastía si viable, resección si necrosis).
5. **Prohibido intentar reducción forzada.**
6. **Profilaxis antibiótica y reanimación previa** son obligatorias.
7. **Pronóstico excelente** si manejo precoz (<6 h), pero mortalidad aumenta con isquemia.